

Análise comparativa pela classificação de Robson da via de parto entre gestantes adolescentes e adultas

Letícia Schimidt Arruda

Sumário

1	1. Introdução	3
2	2. Revisão bibliográfica	6
3	3. Justificativa, Objetivos e Metodologia	13
3.1	3.1 Justificativa e objetivos do estudo	13
3.1.1	3.1.1 Objetivo Geral	13
3.2	3.2 Tipo de estudo e metodologia	15
3.3	3.3 Elegibilidade	16
3.3.1	3.3.1 Critérios de Inclusão:	16
3.3.2	3.3.2 Critérios de Exclusão:	16
3.4	3.4 Questões Éticas	17
3.5	3.5 Análise dos dados	17
4	4. Resultados	18
4.1	4.1 Dados Sociodemográficos	18
4.2	4.2 Tipos de parto: normal, cesárea, fórcepe	19
5	5. Referências Bibliográficas	20

Letícia Schimidt Arruda

Análise comparativa pela classificação de Robson da via de parto entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em série histórica de 25 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia

São Paulo, SP 2026

Letícia Schimdt Arruda

Análise comparativa pela classificação de Robson da via de parto entre gestantes adolescentes precoces, tardias e gestantes adultas em série histórica de 25 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por ocasião do exame de qualificação para obtenção do título de Mestre em Ciências.

Programa de Obstetrícia e Ginecologia Orientador: Prof Dr Marco Aurélio Knippel Galletta

São Paulo 2026

2

“Nosso trabalho acadêmico é, essencialmente, transitivo: é um bordado para outras pessoas admirarem, usarem ou guardarem na estante.” Diniz, Débora.

3

4

Resumo Introdução: Gravidez na adolescência é um tema relevante em saúde pública, pois existem impactos negativos sobre aspectos da vida da gestante adolescente. Além disso, é relevante acompanhar os indicadores sobre a qualidade da assistência obstétrica tanto durante o pré-natal, o parto e nascimento e o durante os cuidados puerperais. Ademais, é importante comparar via de parto de gestantes adolescentes com gestantes adultas. Objetivo: fazer uma análise comparativa da via de parto e fatores associados entre gestantes adolescentes e adultas em série histórica de 25 anos no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo - HC-FMUSP. Metodologia: Estudo transversal de coorte com análise de dados com busca de prontuários em sistemas de dados do HC-FMUSP entre 1995 e 2019 de gestantes adultas de 20 a 34 anos (total 7.074) e gestantes adolescentes de 11 a 19 anos (total 1.677). Resultados: Gestantes adolescentes são submetidas ao uso de fórceps quase três vezes mais do que as gestantes adultas, 30% entre adolescentes contra 10,2% entre as adultas. Enquanto a frequência de cesáreas é quase metade na população adolescente em comparação com as adultas, gestantes adolescentes tiveram cesárea em 30,1% das vezes e as gestantes adultas 62,3%. Conclusão: A análise comparativa mostra que gestantes adolescentes têm menor taxa de cesarianas em relação às adultas, mas ambas as taxas são ainda muito altas. Isso destaca a necessidade de reavaliar as práticas obstétricas e priorizar o parto vaginal seguro, especialmente para adolescentes. Além disso, o alto uso de fórceps entre adolescentes indica a importância de avaliar as práticas obstétricas. É fundamental desenvolver políticas públicas e programas de formação para oferecer uma assistência obstétrica de qualidade, respeitando as necessidades das gestantes adolescentes e promovendo uma experiência de parto segura.

5

Abstract Introduction: Adolescent pregnancy is a relevant public health issue due to its negative impact on various aspects of the adolescent's life. Furthermore, it is important to monitor indicators of obstetric care quality throughout prenatal care, labor and delivery, and postpartum care. Additionally, it is essential to compare the mode of delivery between adolescent and adult pregnant women. **Objective:** To conduct a comparative analysis of the mode of delivery and associated factors between adolescent and adult pregnant women in a 25-year historical series at the Hospital das Clínicas of the University of São Paulo - HC-FMUSP. **Methodology:** A cross-sectional cohort study with data analysis from medical records in HC-FMUSP's data systems between 1995 and 2019, including adult pregnant women aged 20 to 34 years (total 7.074) and adolescent pregnant women aged 11 to 19 years (total 1.677). **Results:** Adolescent pregnant women are subjected to the use of forceps almost three times more than adult pregnant women—30% among adolescents compared to 10.2% among adults. While the cesarean rate is nearly half in the adolescent population compared to adults, adolescent pregnant women had cesareans 30.1% of the time, while adult pregnant women had cesareans 62.3% of the time. **Conclusion:** The comparative analysis shows that adolescent pregnant women have a lower cesarean rate compared to adults, but both rates remain very high. This highlights the need to reevaluate obstetric practices and prioritize safe vaginal delivery, especially for adolescents. Furthermore, the high use of forceps among adolescents indicates the importance of assessing obstetric practices. It is essential to develop public policies and training programs to provide quality obstetric care, respecting the specific needs of adolescent pregnant women and promoting a safe birth experience.

6

1 1. Introdução

A análise da assistência obstétrica fundamenta-se, primordialmente, no monitoramento dos desfechos de partos e nascimentos. Tais indicadores são sensíveis a uma multiplicidade de fatores, que abrangem desde a diversidade dos modelos assistenciais e as características estruturais dos serviços de saúde até o perfil socioeconômico das usuárias e a efetividade do acompanhamento pré-natal. No cenário da saúde pública brasileira, a gravidez na adolescência destaca-se como um grupo de particular vulnerabilidade, sendo amplamente reconhecida pelo incremento na prevalência de complicações maternas e neonatais. Uma das prioridades das políticas públicas é a prevenção da gestação precoce, visando mitigar os riscos biológicos inerentes a uma gestação em corpos ainda em processo de maturação puberal. Ademais, as repercussões desse evento transcendem a relação materno-fetal: as consequências estendem-se ao desenvolvimento de projetos de vida autônomos e às oportunidades de ascensão social, frequentemente cerceadas pelas exigências da maternidade precoce. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) (3), a adolescência compreende o intervalo entre os 10 e 19 anos, caracterizando-se por profundas transformações fisiológicas — como a puberdade — e socioculturais. Sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (4) define a adolescência como o período entre 12 e 18 anos de idade, enfatizando a transição da infância para a vida

adulta sob aspectos físicos, culturais e psíquicos. Embora a menarca e a subsequente ovulação tornem as adolescentes biologicamente aptas à concepção, a precocidade etária correlaciona-se diretamente ao aumento de riscos. 7

Adolescentes jovens (menores de 15 anos) apresentam imaturidade biológica e desenvolvimento pélvico incompleto, condições que podem resultar em desproporção cefalopélvica e trabalho de parto obstruído.²¹ Portanto, a distinção clínica e epidemiológica entre adolescentes precoces (10 a 14 anos) e tardias (15 a 19 anos) é imperativa para a compreensão integral da saúde dessas gestantes. No contexto brasileiro, dados de 2020 revelam que 14% dos nascidos vivos foram provenientes de mães com 19 anos ou menos, totalizando cerca de 380 mil nascimentos.³ Observam-se disparidades regionais acentuadas, com as regiões Norte e Nordeste registrando as maiores proporções de gestações nessa faixa etária.¹ A gravidez em adolescentes precoces (especificamente entre 10 e 14 anos e seis meses), embora represente 0,4% do total de nascidos vivos entre 2011 e 2021, constitui uma grave preocupação de saúde pública.¹² Nestes casos, a gestação frequentemente sinaliza contextos de violência sexual e acarreta implicações sociais e de saúde significativamente mais severas.⁵ Ao comparar mães adolescentes a mulheres adultas, observa-se nas primeiras uma maior prevalência de baixo Índice de Massa Corporal (IMC) pré-gestacional, dependência do financiamento público (SUS), pré-natal inadequado e menores taxas de gemelaridade.¹¹ Em contrapartida, as mulheres adultas apresentam, majoritariamente, maior escolaridade, maior estabilidade conjugal e melhor adesão ao acompanhamento pré-natal.¹² O fator étnico-racial também é determinante: em 2020, 28,2% dos nascidos vivos de mães indígenas eram de adolescentes, seguidos por 16,7% entre mulheres pardas e 13% entre pretas, contrastando com 9,2% entre mães brancas.⁶ Evidencia-se, assim, que a gravidez na adolescência não é um fenômeno meramente biológico, mas o resultado de uma interação complexa entre imaturidade 8

orgânica, vulnerabilidade socioeconômica e barreiras no acesso a serviços de saúde e métodos contraceptivos. Os riscos para gestantes precoces incluem maior morbidade e mortalidade materna¹, além de complicações como síndromes hipertensivas e pré-eclâmpsia¹, anemia¹, prematuridade¹, diabetes mellitus gestacional⁴, infecções sexualmente transmissíveis⁴ e hemorragia pós-parto.⁴ (1,2). Estudos de Adeyinka et al. (2010) indicam um risco duas vezes superior de complicações obstétricas em adolescentes comparadas a adultas. Ademais, Conde-Agudelo et al. (2005), em análise de mais de 800 mil partos na América Latina, apontam que o risco de morte materna em menores de 16 anos é quatro vezes maior, somando-se a riscos elevados de parto instrumentalizado, episiotomia e endometrite. (10,11) A literatura corrobora que desfechos adversos estão intrinsecamente ligados ao início tardio e à baixa frequência do pré-natal.¹³ O manual de gestação de alto risco⁴ associa o parto prematuro ao baixo ganho de peso ponderal e a curtos intervalos intergestacionais. Em adolescentes muito jovens, o atraso no cuidado pré-natal é frequentemente exacerbado por situações de violência sexual, em que o agressor dificulta o acesso aos serviços de saúde.¹² Essa cadeia de eventos demonstra que a vulnerabilidade social intensifica os riscos biológicos, exigindo intervenções multifacetadas que integrem cuidados clínicos, suporte educacional e prevenção da violência. No que tange aos desfechos de parto, o Brasil apresenta taxas de cesariana de aproximadamente 56%, excedendo vastamente os 15% recomendados pela OMS. A cesárea, quando realizada sem indicação

clínica precisa, eleva os riscos de ruptura uterina, anomalias placentárias, gravidez ectópica e natimortalidade em gestações subsequentes. (12) Evidências 9

indicam que o nascimento por via cirúrgica altera a fisiologia neonatal devido a diferentes exposições hormonais e bacterianas, podendo resultar em desenvolvimento imunológico alterado, asma e redução na diversidade da microbiota intestinal. (13) Em adolescentes, a cesárea é particularmente preocupante, pois compromete uma vida reprodutiva que se iniciou precocemente, aumentando a probabilidade de múltiplas cirurgias subsequentes. Silver et al. (2006) identificaram um aumento progressivo da morbidade materna grave conforme o número de cesáreas acumuladas. (16) No mesmo sentido, Mascarello et al. observaram altas proporções de partos operatórios tanto no primeiro nascimento quanto nos seguintes, o que representa um desafio de longo prazo para a saúde pública. Uma revisão sistemática com meta-análise indicou que a cesárea eleva em 1,33 vez o risco de sobrepeso e obesidade na prole, com efeitos acentuados em adolescentes. No entanto, ainda há escassez de análises específicas comparando o impacto desses riscos entre filhos de mães adolescentes e adultas. (14) Diante desse cenário, mudanças nas políticas de atendimento são fundamentais para preservar o futuro reprodutivo dessas jovens. (15) Para enfrentar esse desafio, a OMS recomendou, em 2015, o uso da Classificação de Robson (Sistema de Classificação de Dez Grupos).⁷ Este método permite comparar taxas de cesariana de forma padronizada, fornecendo subsídios epidemiológicos para investigar as causas do aumento dessas taxas e promover intervenções baseadas em evidências.⁷ A classificação é prática, reprodutível e categoriza as gestantes em grupos mutuamente exclusivos com base em: paridade, histórico obstétrico, tipo de gestação, início do trabalho de parto e idade gestacional.⁷ 10

A vigilância obstétrica define-se como a coleta sistemática de dados para aprimorar a assistência e formular protocolos específicos. No Brasil, embora a razão de mortalidade materna apresente tendência de declínio, a erradicação de mortes evitáveis permanece um desafio substancial. (Nota: Inserir dado aqui — Ex: atualmente em 110 óbitos por 100.000 nascidos vivos). Considerando a relevância da gravidez na adolescência e seus desfechos, este estudo busca analisar as taxas de partos operatórios em adolescentes comparadas a adultas, no contexto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP). A relevância do HC-FMUSP reside em sua atuação como centro de excelência com atendimento multiprofissional especializado. Uma análise retrospectiva nesta instituição é fundamental para avaliar a efetividade das práticas clínicas locais, identificar oportunidades de melhoria na assistência e contribuir para a produção de conhecimento científico contextualizado, fortalecendo a formação acadêmica e a formulação de políticas internas baseadas em dados. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangendo a literatura do último século sobre via de nascimento e gravidez na adolescência. A metodologia deste estudo fundamenta-se na análise de dados institucionais recentes, organizados e categorizados pelos dez grupos de Robson, permitindo uma investigação detalhada das principais indicações cirúrgicas, complicações e desfechos obstétricos.

2 2. Revisão bibliográfica

No contexto histórico da pós Revolução Industrial, as jovens logo após a menarca já eram aceitas como mulheres adultas ao contarem com todos os seus requisitos biológicos para a procriação. Williams, em 1919, na primeira edição de seu compêndio, já estabelecia que o trabalho de parto e o parto em mulheres abaixo de 16 anos não eram mais perigosos ou difíceis do que em mulheres em idades mais maduras. Pouco depois, em 1922, Harris, ao reportar uma taxa de cesárea de 2,2% no Johns Hopkins Hospital, concluía: “falando do ponto de vista puramente obstétrico, a idade abaixo dos 16 anos parece ser a melhor época para a ocorrência do primeiro trabalho de parto”. (18) Nesta época, o que se esperava de jovens após a menarca, era que se pudesse ter filhos. Não havia, exatamente, a definição da adolescência como um processo biopsicossocial transitório. Essa definição acontece com a necessidade do preparo para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a necessidade do estudo dessa faixa etária e tempo para que a pessoa conseguisse se estabelecer com uma profissão e uma possível ascensão econômica e, consequentemente, social. Pela publicação citada acima, vemos que a análise foi realizada exclusivamente sob o viés biológico e com base no período. Em 1922, no Rio de Janeiro, 85,2% dos partos eram realizados por leigas e apenas 14,8% por parteiras diplomadas e médicos. O país tinha poucas maternidades e poucos leitos hospitalares para gestantes. Em São Paulo, até a década de 1920, o atendimento era limitado a poucas maternidades, com apenas 60 leitos na Maternidade de São Paulo em 1925. O censo de 1935-1936 registrou 710 leitos para gestantes no estado, número insuficiente para atender à demanda. Nas décadas de 1930 e 1940, houve um aumento no número de hospitais e maternidades, ocorrendo o surgimento do Hospital das Clínicas em 1944, que atendia gestantes pobres e formava profissionais de saúde. Em 1945, o percentual de partos hospitalares aumentou para 29,5%, mas a maioria ainda ocorria em casa, com maior taxa de natimortalidade nos 12

hospitais, como apresentou Mott em sua pesquisa publicada em 2002. (19) No Brasil, o cenário obstétrico foi se alterando com maior velocidade a partir dos anos seguintes. Com uma mudança importante no paradigma de atenção obstétrica a partir da década de 80. (20) Desde 1930, há um aumento crescente do número de mulheres no mercado de trabalho. Foi a partir de 1950, no cenário mundial e, inclusive, no Brasil, que ocorreu o ingresso massivo de mulheres no mercado de trabalho. Nessa época, a fecundidade passa a ser um foco de debate, uma vez que as relações de gênero iniciam um processo de transformação, com a necessidade de cuidado parental, cuidado da casa e a manutenção do trabalho fora do domicílio. Nesse período, a adolescência passa a ser entendida para além do aspecto biológico e, entre as mudanças observadas, destaca-se uma maior atenção da saúde pública à gestação nessa fase. Isso se deve tanto aos riscos envolvidos quanto ao impacto na continuidade dos estudos e os determinantes sociais. (21) Em “Opacidade e visibilidade da paternidade na reprodução adolescente”, Reis realiza uma análise de conteúdo sobre “adolescência e gravidez” e conclui que, entre 1950 e 1959, foram identificados, no Index Medicus, 28 artigos sobre o tema, dos quais 11 foram realizados nos Estados Unidos. (22) Em um artigo do Hospital de Chicago, publicado em 1950, foram avaliados desfechos de partos de 186 adolescentes entre 13 e 16 anos; cinco casos tiveram diagnóstico de desproporção céfalo-pélvica, quatro tiveram cesáreas e um caso limítrofe teve

resolução por fórcepe baixo. Ao todo, considera-se, por esse estudo, 2,5% de partos operatórios. Ainda que a sociedade começasse a discutir sobre maiores preocupações em relação à gestação na adolescência, eles citam que o parto nessa fase da vida não representa risco maior do que quando comparado com primigestas adultas. Todas as pacientes primíparas deste estudo pariram com bloqueio do nervo pudendo e episiotomia médio-lateral. Cinco partos ocorreram espontaneamente. (23) 13

Em relação aos riscos da gravidez na adolescência, um estudo comparativo realizado na década de 60, após análise por 6 anos de acompanhamento de 100 gestantes adolescentes primigestas de 13 a 16 anos com ascendência inglesa e holandesa, comparadas com 100 gestantes com 22 anos em um hospital em Cape Town, concluiu que as adolescentes apresentaram maiores complicações na comparação com gestantes adultas, como transtornos hipertensivos e prematuridade. No entanto, quando analisado o desfecho de parto, 88% das gestantes adolescentes tiveram partos normais, contra 80% das adultas. Dez por cento das gestantes adolescentes tiveram partos via fórcepe contra 17% no grupo das gestantes adultas; e apenas 1% teve cesariana como via de parto, contra 3% das adultas. (24) Em outro estudo realizado em 1964 por Mohammed Hassan nos Estados Unidos, compreende-se que: Jovens primíparas com 15 anos ou menos na época do parto devem ser consideradas uma entidade obstétrica, devido ao aumento do risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Um excelente cuidado pré-natal e uma observação rigorosa devem ser adotados para proteger tanto a mãe quanto o bebê.

Nele, houve a comparação de gestantes adolescentes entre 12 e 15 anos (159 casos) com grupo controle de gestantes com 22 anos (78 casos). Nascimentos via fórcepe no grupo das adolescentes foram de 20,1%, contra 24,2% no grupo das adultas. Quando Hassan et al. compararam a quantidade de nascimentos via cesariana, chegaram à conclusão de que no grupo das adolescentes houve 3,1%, sem nenhum caso nas adultas. (25) Os anos 70 mantém o predomínio dos trabalhos estadunidenses. Em um estudo de 1979, Hutchins et al. observou uma queda da taxa de fecundidade entre mulheres mais velhas, enquanto houve um aumento de aproximadamente 20% entre adolescentes de 15 a 17 anos. Foram estudadas, ao todo, 4.224 parturientes adolescentes, equivalente a 42% dos nascimentos do 14

período, sendo que os demais nascimentos ocorreram no grupo de mulheres de 20 a 34 anos. Tal hospital, cuja pesquisa foi realizada, atendia de forma majoritária a população economicamente desfavorecida, a população negra e também uma parcela de porto-riquenhos. Em relação ao desfecho do parto, a taxa de cesárea entre as adolescentes menores de 17 anos foi de 5,5%, e entre 17 e 19 anos a taxa foi de 6,5%, enquanto no grupo das adultas de 20 a 34 anos foi de 8,1%. (26) Na década de 80, autores brasileiros começaram a pesquisar o tema. Em 1981, Siqueira et al. avaliaram os desfechos de gestantes adolescentes matriculadas em um serviço em São Paulo. Ao todo, admitiram 136 gestantes acompanhadas entre janeiro de 1969 a dezembro de 1978. Entre as adolescentes, houve um caso sem informação sobre o parto e o mesmo foi excluído para este quesito. Como resultado, observou-se que 92 tiveram parto normal, 24 tiveram fórcepe e 19 tiveram cesárea. As parturientes adultas, que foram usadas como grupo controle, tiveram parto normal em 68 casos, fórcepe em 11 casos e cesárea em 50 casos. Proporcionalmente, o grupo das gestantes adolescentes teve menos cesárea do que o das adultas e maior porcentagem

de parto normal. Já quando analisamos os casos de parto com fórceps temos 17,8% entre as adolescentes, contra 8,5% entre as adultas.(27) Em 1982, Costa apresenta os dados de um outro estudo brasileiro pioneiro, com adolescentes de Recife - Pernambuco, onde se analisam dois grupos de primigestas, um com adolescentes entre 13 e 15 anos, e o segundo com adultas de 18 a 20 anos. A taxa de cesárea foi significativamente maior nas adolescentes (14,8%), do que nas adultas (7,7%). A principal indicação foi desproporção céfalo-pélvica, em 29,7% das adolescentes e 14,3% das adultas. (28) Beleza Filho et al. (1984) realizaram outro estudo em maternidade de Florianópolis, Santa Catarina, comparando 65 adolescentes (17 anos) e 919 adultas (18-25 anos). Dentre as adolescentes, 18,46% foram submetidas à cesárea, assim como 21,54% das adultas, diferença 15

essa não significativa. As primeiras indicações nas adolescentes foram: desproporção céfalo-pélvica e sofrimento fetal. Nas adultas, a primeira indicação foi apresentação pélvica, seguindo-se desproporção céfalo-pélvica e distócia cervical. (29) Mathias et al., em 1985, publicaram dois trabalhos sobre o resultado obstétrico da gravidez na adolescência, com a experiência do Hospital das Clínicas da FMUSP. No primeiro (Mathias et al., 1985a) descreveram os dados de parto de 105 adolescentes precoces (9 a 15 anos), ocorridos na instituição, com 30,5% de cesáreas, 33,4% de partos fórceps e 36,1% de partos normais. As cesáreas foram indicadas por sofrimento fetal (42,4%), eclâmpsia (18,1%), hímen íntegro (12,1%), vício pélvico (6%), fórceps falhado (3,1%) e distocia funcional (3,1%). Dentre as complicações do parto, ocorreram 3 casos de laceração de colo, 1 caso de deiscência em períneo, 1 caso de acretismo + hemorragia, e 1 caso de cefaléia pós-raqui, correspondendo a uma taxa global de 5,71% de complicações do parto e puerpério. (30) No segundo trabalho em 1985, Mathias et al. compararam dois grupos de adolescentes: um com 242 gestantes entre 9 e 16 anos (grupo 1) e um outro com 315 gestantes entre 17-19 anos (grupo 2), com a intenção de estabelecer qual seria a idade limite de risco reprodutivo. O primeiro grupo teve pior acompanhamento pré-natal, com apenas 12% delas alcançando cinco ou mais consultas pré-natais, além de mais pacientes solteiras. Apesar disso, a incidência de parto cesárea foi semelhante entre os dois grupos: 29,3% vs. 29,5%. Já para comparação de parto com fórceps, a taxa foi de 34,1% entre as gestantes adolescentes mais novas e 42,3% entre as gestantes adolescentes mais velhas. Para o grupo de gestantes adolescentes mais novas, as indicações de cesárea foram: sofrimento fetal, eclâmpsia e desproporção céfalo-pélvica. Para o grupo de gestantes mais velhas, as indicações são um tanto distintas: apresentação anômala, distócia funcional, hipertensão arterial e amniorrexe prematura. Com relação às complicações, a lesão de partes moles foi mais frequente entre as gestantes mais velhas: 6,6% contra 1,2% no 16

caso de gestantes adolescentes. A infecção teve distribuição similar: 1,6% no primeiro grupo e 1,9% no segundo. Assim, parecia que não havia diferença no risco para cesárea entre a adolescente mais nova e a mais velha, havendo no entanto diferença em relação ao tipo de indicação da cesárea e no tipo de morbidade pós-parto. (31) Já em outro estudo realizado na cidade de São Paulo em 1986, comparando gestantes adolescentes e gestantes adultas, Lopes Alegria et al. identificaram que as adolescentes tiveram uma maior proporção de partos cirúrgicos, com 25,7% de partos com fórceps e 22,9% de cesarianas, em comparação com 14,7% e 19,7%, respectivamente, para as gestantes adultas. O número de gestantes desta pesquisa foi

de 349. (32) O crescimento do destaque para tema obstétrico no Brasil foi além das pesquisas acadêmicas. Foi durante a década de 80 que tivemos diversas políticas públicas propostas na área da saúde, inclusive programas de cuidado da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que englobavam o público adolescente. Durante estes anos, o cuidado à mulher passou a ser entendido como integral, ou seja, abordando tanto os aspectos clínico-ginecológicos e educativos, com foco no aprimoramento do acompanhamento pré-natal, no cuidado durante o parto e puerpério, quanto às questões de saúde que se estendem desde a adolescência até a terceira idade, como por exemplo controle de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer cervical e de mama além dos métodos contraceptivos e planejamento familiar. (33) Com o aumento da discussão acadêmica e programas de saúde, Siqueira et al. em sua pesquisa observaram que o sexto maior grupo com mortes maternas pertencia ao grupo das adolescentes, segundo o CENSO de 1980. Nesta pesquisa, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), concluiu-se que as complicações da gravidez, parto e puerpério foram responsáveis por 4% dos óbitos de adolescentes de 10 a 19 anos. Quando o foco é colocado nas adolescentes tardias, na faixa de 15 a 19 anos, os óbitos decorrentes das 17

complicações totalizaram 6,1%. As principais causas de óbito por complicações da gravidez, parto e puerpério foram os estados hipertensivos, as infecções puerperais, as hemorragias e os abortos. Isso reforça a importância da atenção obstétrica adequada. O olhar para concepção e contracepção da adolescência à terceira idade ressalta também a necessidade da continuidade do cuidado da saúde reprodutiva das mulheres. (27) Em São Paulo em 1987 tem o início do serviço de atendimento à gestante adolescente no Hospital das Clínicas da FMUSP, o PIAEGA (Programa Integrado de Assistência e Educação a Gestante Adolescente), que foi pioneiro no Brasil com foco em atendimento específico à adolescente com equipe multiprofissional. (34) Foi também ao final da década de 80 e início dos anos 90 que tivemos a demarcação dos direitos de adolescentes reconhecidos pela Constituição Brasileira (1988) e, na sequência, a criação do ECA em 1990. Com essa mudança de cenário das políticas públicas, e a crescente necessidade de se cuidar do acesso à saúde das gestantes adolescentes com número que seguiu aumentando em nosso país, houve criação de alguns serviços de atendimento específico para esse público, como o caso do Centro de Atendimento à Mulher Adolescente (CEAMA), localizado no Rio de Janeiro. O projeto conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiras, médicos e psicólogos. Em 2001, o CEAMA realizou 3.970 consultas para adolescentes gestantes, e em 2003 esse número triplicou, alcançando 11.199 atendimentos. (35) O crescimento do número de adolescentes grávidas observado no Brasil era também observado em outros lugares do mundo. Nos EUA, Spitz et al. fizeram uma análise comparando a quantidade de nascimentos de gestantes adolescentes em 1980, 1985 e 1990 e concluíram que, apesar dos esforços para reduzir a gravidez na adolescência, as taxas de gravidez e parto para adolescentes eram as mais altas entre os países desenvolvidos. Os autores ainda enfatizaram 18

que, considerando que 95% das gestações adolescentes não são planejadas, os esforços para prevenir essas gravidezes deveriam ser intensificados. (36) No quesito desfecho de parto, na Grécia, em 1991, Creatsas et al. realizaram um estudo prospectivo com três grupos de primigestas, totalizando mais de duas mil pacientes. O primeiro grupo consistia em adolescentes de 13 a 19 anos, o segundo era composto por adultas de 20 a 35 anos, e o terceiro grupo era

com mulheres com mais de 35 anos. A taxa de cesárea entre as adolescentes foi de apenas 6,64%, enquanto nos dois grupos de adultas foi de 19,47% e 40,45%, respectivamente. A taxa de uso de fórceps foi de 9,48%, 11,42% e 7,87%, respectivamente. Esses índices favoráveis às adolescentes podem estar relacionados à qualidade do pré-natal, que incluía entrevistas com psicólogos e assistentes sociais. Isso contribuiu para a redução da interferência do baixo nível socioeconômico, mais acentuado entre as adolescentes, sobre o risco obstétrico. (37) Em 1991, Aleixo realizou uma análise retrospectiva dos arquivos de um hospital no Rio de Janeiro, com base em grupos aleatórios de 577 gestantes adolescentes (12 a 16 anos) e 577 adultas (25 a 35 anos), atendidas entre 1925 e 1975. A taxa de partos operatórios entre as adolescentes foi quase o dobro da observada nas adultas, tanto para cesarianas (10,1% contra 5,4%) quanto para partos com fórceps (5,2% contra 2,6%). Durante esse período, a taxa de mortalidade materna também foi mais alta entre as adolescentes, 0,7% contra 0,3%, possivelmente devido a complicações no parto. O autor também menciona dados não publicados de outra maternidade pública do Rio de Janeiro, onde a taxa de cesárea entre adolescentes era de 6,25% em 1985, subindo para 14% em 1990. Esse aumento é semelhante ao observado no hospital já citado, onde a taxa de cesárea na mesma faixa etária foi de 18%. (38) Em contraste, alguns estudos da mesma época não demonstraram diferenças significativas nos tipos de parto entre gestantes adolescentes e adultas. Em uma pesquisa de 19

1991 com análise dos dados de parto de 286 primigestas menores de 17 anos, comparando-as com 267 primigestas adultas jovens (21 a 25 anos), atendidas em um hospital universitário da Louisiana, Estados Unidos, Brown et al. destacaram que ambos os grupos apresentaram características socioeconômicas e raciais semelhantes. Quanto ao pré-natal, embora os dois grupos tivessem iniciado a assistência na mesma época da gravidez, uma menor proporção de adolescentes teve menos de 5 consultas (8% contra 25%, com diferença significativa). Não houve diferença estatisticamente significativa no tipo de parto, com 12 casos (4%) de cesárea entre as adolescentes, em comparação com 14 casos (5%) entre as adultas. Esse melhor resultado obstétrico pode estar relacionado à maior cobertura pré-natal das adolescentes. (39) Galletta et al., em 1997, estudaram os dados de 100 gestantes adolescentes (11-18 anos) com pré-natal e parto no Hospital das Clínicas da FMUSP, a partir de um total de 327 gestantes acompanhadas em pré-natal multiprofissional especializado e notaram uma incidência de cesárea de 31%, assim como de fórceps de 54%, com 11% de partos normais. Interessantemente, diversos dados antropométricos e biológicos não se correlacionaram com as taxas de parto operatório. (40) Lippi et al., em 2000, realizaram um novo levantamento de resultados obstétricos das pacientes do Setor de Gravidez na Adolescência do Hospital das Clínicas, com dados de 435 parturientes, no qual se pode perceber taxas semelhantes de parto cesárea (30,3%). (41) Em 2001, Costa et al. realizaram um estudo com 2.194 filhos de adolescentes (de 10 a 16 anos) e 3.085 filhos de mulheres adultas jovens (de 20 a 24 anos), utilizando dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) na região de Feira de Santana, Bahia. Os autores relataram que apesar das adolescentes apresentarem menor escolaridade, pior assistência pré-natal e maior incidência de recém-nascidos com baixo peso, as taxas de cesárea entre elas foram apenas ligeiramente inferiores às das gestantes adultas (19,2% entre as adolescentes contra 22% entre as adultas). (42) 20

Carniel et al. publicaram em 2006 um estudo, realizado na cidade de Campinas, sobre fatores sociodemográficos durante a gravidez na adolescência. Os autores reportaram dados de gestações de adolescentes que ocorreram em 2001 e descreveram o perfil dessas gestantes. Conforme os resultados, as adolescentes gestantes apresentaram o seguinte perfil: 48,4% tinham até sete anos de estudo, 59,9% não tinham companheiro, 87,6% não trabalhavam, 46% viviam em regiões com baixas condições de vida; a maioria era primípara, 21,6% tinham um filho ou mais, 35,2% fizeram menos que sete consultas no pré-natal, 36,2% dos partos foram via cesárea. O total dos dados de gestantes adolescentes foi de 2.563 nascimentos ao longo do ano de 2001. Ainda na década de 2010, uma revisão sistemática, de 15 artigos publicados de 2002 a 2012 (dos quais seis eram brasileiros), tratando de complicações da gravidez na adolescência observou menor prevalência de cesárea em adolescentes (média de 26% entre todos os trabalhos brasileiros) do que na população geral (média de 43% por dados do Ministério da Saúde). (43) (44) Velho, em 2019, realizou uma pesquisa com 2.668 partos em adolescentes brasileiras sem comorbidades, e reportou que 48% foram espontâneos, 14% induzidos e 38% foram cesáreas programadas (45), o que ultrapassa os 15% de cesáreas recomendados pela Organização Mundial da Saúde (46), aumentando os riscos e reduzindo os benefícios das intervenções. Quando comparadas as taxas de parto entre adultas e adolescentes, outro estudo de 2000 com amostra de 11.501 mulheres na Zâmbia (47) demonstrou que as adolescentes apresentaram uma taxa um pouco menor (1,5%) de parto cesárea do que as mulheres adultas, seja entre 20-34 anos (1,7%), seja maior do que 35 anos (2,3%). No entanto, tiveram maiores índices de parto distócico (parto obstruído ou prolongado) do que as adultas: 2,8% vs. 2,2%. Interessantemente, observou-se menor assistência médica ao parto entre as adolescentes (1,7%) do que entre as adultas (2,4% naquelas entre 20 e 24 anos ou 3,5% entre aquelas > 35 anos). 21

Em um estudo de coorte retrospectivo, publicado em 2017, com 8 anos de coletas de dados em um hospital universitário na Romênia, o então país com a maior taxa de gravidez na adolescência da Europa, Socolov et al. analisaram comorbidades de gestantes primigestas e compararam os parâmetros relacionados ao parto de adolescentes com idade inferior a 20 anos e jovens adultas com idade de 20 a 24 anos. Os autores reportaram que adolescentes apresentavam menor risco de cesariana do que as adultas. (48) É importante dizer que a qualidade da atenção pré-natal parece estar diretamente associada à melhoria dos desfechos de parto e nascimento. Campos fez uma análise em 2022 (49) das gestantes adolescentes participantes do inquérito nacional Nascer no Brasil de 2015 (50), e constatou que:

As puérperas na faixa etária de 12 a 16 anos apresentavam condições mais precárias de vulnerabilidade socioeconômica, recebiam atenção inadequada durante o pré-natal e o parto, além de enfrentarem complicações neonatais em seus bebês, o que ressalta a necessidade de um acompanhamento multiprofissional direcionado a essas adolescentes.

Ou seja, como outros autores enfatizam, a falta de acompanhamento pré-natal adequado estaria vinculada ao aumento das complicações durante a gestação, no parto e no pós-parto, como demonstraram também Nam et al., em pesquisa de 2022. (51) O acesso ao pré-natal é, muitas vezes, dificultado por questões socioeconômicas. Wong et al. com uma amostra canadense de 25.263 gestantes, reportaram que 4,3% eram adolescentes com 19 anos ou menos, 18% viviam

em condições econômicas vulneráveis, um número significativamente maior que os 11% das gestantes entre 20 e 34 anos e os 9% das gestantes acima de 35 anos. (52) Além disso, 22

Bussink-Voorend em pesquisa realizada em Sierra Leoa, destacou que as taxas de adolescentes gestantes sem acompanhamento pré-natal eram elevadas (16,4%) e que problemas como depressão e abuso de substâncias (tabaco, álcool, maconha) eram mais comuns entre as gestantes adolescentes em comparação com as adultas. (53) Podemos perceber, ao analisar a literatura, que as taxas de parto operatório em adolescentes, e mais especificamente de cesárea em adolescentes, são muito diversas de serviço para serviço, com pouca ou nenhuma explicação dos autores sobre tais diferenças, nem sempre há descrição sobre as reais indicações ou fatores associados. Há um aumento de partos operatórios e da medicalização de parto em geral na maior parte dos países do mundo. No Brasil, as taxas de nascimento via cirúrgica têm uma curva crescente ao longo do tempo, suscitando questionamento sobre quando as intervenções nas parturientes deixam de ocupar um lugar de benefício para trazer mais riscos ao serem aplicadas. O uso de cesárea tem crescido de maneira constante em todo o mundo e continuará a aumentar na próxima década, com exceção de alguns locais que sofrem com a coexistência de uma necessidade não atendida e do uso excessivo, o paradoxo do acesso excessivo em muitos lugares e a restrição ao acesso de outros locais, em ambos cenários, há o aumento da morbimortalidade materna e neonatal. Na falta de intervenções globais eficazes para reverter essa tendência, enfrentaremos um cenário complexo, marcado pela morbidade e mortalidade relacionadas à necessidade não atendida e à prática insegura de cesárea. Enquanto lugares como no Sul da Ásia e na África Subsaariana há menor acesso para a realização de intervenções no parto e cesarianas, quando necessárias, causando aumento da morbimortalidade materna e neonatal. O uso excessivo deste procedimento compromete recursos, aumenta riscos para população e resulta em danos evitáveis. (54) Com base em buscas sistemáticas da literatura, até o momento, não há uma meta-análise após a de Scholl et al. em 1994, que compare diretamente os tipos e desfechos de parto entre gestantes adolescentes e adultas. No entanto, diversos estudos individuais fornecem 23

resultados valiosos sobre as diferenças nos desfechos obstétricos entre esses grupos. Scholl et al. (1994) analisaram mais de 20 estudos que compararam adultas e adolescentes em relação ao tipo de parto. A pesquisa constatou que, independentemente da época (décadas de 70 a 90), não havia diferença estatística significativa entre os grupos, com um risco relativo (RR) de 0,90 para cesáreas entre adolescentes (IC95%: 0,76-1,06). No entanto, nos países desenvolvidos, o RR para adolescentes foi de 0,74 (IC95%: 0,57-0,96), geralmente associado a um pré-natal multiprofissional diferencial. Em contraste, em países em desenvolvimento, o risco para adolescentes foi maior, com um RR de 1,22 (IC95%: 1,02-1,45). A revisão da literatura realizada até aqui deixa claro que persiste a dúvida sobre o real risco da gestante adolescente para o parto cesárea, com artigos indicando risco e outros não. Com apenas uma meta-análise sobre o assunto, publicada há mais de 30 anos, vimos a oportunidade de realizar uma revisão sistemática mais atualizada. Nosso grupo de pesquisa está em vias de submissão de uma meta-análise com 153 artigos, publicados entre 1980 e 2023, (in prep.) comparando a prevalência do parto cesariana entre gestantes adolescentes e adultas, incluindo 6.657.585 partos. Na análise global, as gestantes adolescentes apresentaram risco 22% menor para o parto

cesárea em comparação com gestantes adultas (RR = 0,77; IC 95%: 0,77 a 0,78). Quando analisamos por décadas, observamos uma leve tendência de diminuição no risco para parto cesárea. Por outro lado, observamos maior risco entre as adolescentes africanas (RR = 1,14; IC95%: 1,09-1,19), e risco menor entre as adolescentes europeias (RR = 0,64; IC95%: 0,62-0,67). (55) <https://dacemirror.sci-hub.se/journal-article/38547a51232353cbee3095ad9d43002b/robson2001.pdf#navpanes=0&view=FitH> (citar Robson) O sistema de classificação de Robson foi publicado em 2001 com objetivo de propor uma estrutura para a análise das taxas de cesárea e suas amplas implicações (para mulheres, famílias, profissionais e sociedade), fomentando um debate mais embasado. Enfatiza-se que a 24

interpretação das taxas e as consequentes mudanças no manejo para aprimorar a qualidade do cuidado são responsabilidade de cada instituição de saúde. Por fim, sugere-se que o sistema de classificação mais eficaz na prática será aquele com maior robustez teórica. Desde desta publicação existe o consenso da necessidade de monitorizar e acompanhar as taxas de partos, intervenções e cirurgias para que seja possível acompanhar e propor melhoras em serviços de saúde diversos com atendimento obstétrico.

3 3. Justificativa, Objetivos e Metodologia

3.1 3.1 Justificativa e objetivos do estudo

Diante do quadro descrito acima, podemos perceber não apenas a importância do tema da gravidez e parto na adolescência, como também a falta de dados mais assertivos sobre o real risco da gestante adolescente no tocante ao parto cesárea e suas complicações. Há dados conflitantes na literatura e não se sabe de fato se a gestante adolescente apresenta ou não maior risco para o parto operatório. Outrossim, não se sabe se as indicações para o parto cesárea, seus fatores relacionados e as complicações seriam diferentes entre gestantes adolescentes e adultas. Assim, notamos a oportunidade de contribuir cientificamente sobre esse tema, ao termos à disposição dados confiáveis de uma série histórica num serviço terciário bem organizado e com protocolo assistencial bem definido, contando inclusive com um pré-natal multidisciplinar com experiência de três décadas na assistência à essa faixa etária específica, sendo possível fazer uma análise comparativa entre gestantes adolescentes e adultas. Dispomo-nos então a realizar o presente estudo, investigando as características do parto na comparação entre gestantes adolescentes e adultas. 25

3.1.1 3.1.1 Objetivo Geral

Analisar comparativamente dados sociodemográficos com desfechos de parto (vaginal espontâneo, fórcepe e cesárea), as principais indicações de parto operatório e as complicações maternas entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas, segundo os grupos da Classificação de Robson, em atendimentos realizados no HC-FMUSP no período de 1995 a 2017.. Analisar

comparativamente os desfechos de parto – incluindo as vias de parto, as indicações de parto operatório e as complicações maternas – entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas, segundo os grupos da Classificação de Robson, e o perfil sociodemográfico associado, em atendimentos realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) no período de 1995 a 2017. - Caracterizar o perfil sociodemográfico: Descrever e comparar as características sociodemográficas (como idade, escolaridade, estado civil) das gestantes adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas atendidas no HC-FMUSP durante o período do estudo. - Comparar as vias de parto: Comparar as taxas das diferentes vias de parto (vaginal espontâneo, parto vaginal instrumentado/fórceps, e cesárea) entre os grupos de gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas. Adicionalmente, analisar a distribuição dessas vias de parto nos grupos da Classificação de Robson para cada faixa etária. - Mapear as indicações de parto operatório: Identificar e comparar as principais indicações clínicas para a realização de partos operatórios (cesáreas e partos vaginais instrumentados) segundo a classificação de Robson entre gestantes adolescentes e adultas, verificando se há diferenças na prevalência dessas indicações entre os grupos. 26

JUSTIFICATIVA: A saúde materno-infantil representa uma prioridade global, e a análise dos desfechos de parto é fundamental para o monitoramento da qualidade da assistência obstétrica e para a formulação de políticas de saúde eficazes. No Brasil, a gestação na adolescência persiste como um desafio de saúde pública, associada a um maior risco de desfechos perinatais adversos, como prematuridade, baixo peso ao nascer e complicações maternas, além de repercussões psicossociais e econômicas para as jovens mães, suas famílias e a sociedade. Diferenciar adolescentes em fases precoces (10-14 anos) e tardias (15-19 anos) é particularmente relevante, uma vez que os riscos e as necessidades podem variar significativamente entre esses subgrupos devido a diferenças maturacionais biológicas, psicológicas e sociais. Paralelamente, as taxas de cesariana no Brasil são consistentemente elevadas, ultrapassando em muito os 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que configura um importante problema de saúde pública. A Classificação de Robson, recomendada pela OMS, surge como uma ferramenta padronizada e essencial para monitorar, comparar e compreender os fatores que contribuem para as taxas de cesariana em diferentes populações e instituições, permitindo a identificação de grupos de mulheres com maior impacto nesses índices e o direcionamento de intervenções mais efetivas. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), como um dos maiores complexos hospitalares e centro de referência para casos de alta complexidade na América Latina, acumula um vasto volume de dados ao longo de décadas. A análise de um período extenso, como o de 1995 a 2017, permite não apenas um retrato robusto dos desfechos obstétricos, mas também a observação de tendências e possíveis mudanças no perfil das pacientes e nas práticas assistenciais ao longo de 25 anos. Compreender as particularidades dos desfechos de parto – incluindo as vias de parto, as 27

principais indicações de partos operatórios (cesáreas e fórceps) e as complicações maternas associadas – entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas neste cenário é crucial. Apesar da existência de estudos sobre gestação na adolescência e sobre o uso da Classificação de Robson, há uma lacuna na literatura no que tange a uma análise comparativa detalhada e de longo prazo que contemple simultaneamente o perfil sociodemográfico, os desfechos de parto

estratificados pelos grupos de Robson, as indicações de parto operatório e as complicações maternas, comparando especificamente adolescentes precoces, tardias e adultas em um grande centro de referência terciário brasileiro. Este estudo propõe preencher essa lacuna, oferecendo um panorama abrangente e específico do HC-FMUSP. Portanto, a realização deste estudo justifica-se por sua relevância epidemiológica, social e científica, com potencial para gerar impacto positivo na qualidade da assistência obstétrica e na saúde materno-infantil.

3.2 3.2 Tipo de estudo e metodologia

A fim de atender os objetivos propostos, realizamos uma análise transversal e comparativa de coorte histórica no período de cerca de 25 anos, com a utilização de dois bancos de dados referentes aos partos de gestantes adolescentes e gestantes adultas no HC-FMUSP. O primeiro banco de dados refere-se a informações obtidas das gestantes adolescentes atendidas no ambulatório do Setor de Gravidez na Adolescência do HC-FMUSP, enquanto o segundo, às informações de gestantes adolescentes e adultas que foram atendidas pela enfermaria do HC-FMUSP. A seguir, descreveremos sobre o histórico e como os dados foram coletados pela instituição citada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (3), adolescência é o período de tempo que vai de 10 a 19 anos de idade e é uma época composta por inúmeras mudanças tanto do 28

campo fisiológico, como a puberdade, quanto relativo ao campo sociocultural. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (4), conjunto de normas de ordenamento jurídico em território brasileiro, a adolescência é o período que vai de 12 a 18 anos de idade e compreende a transição da infância para a vida adulta, considerando aspectos físicos, culturais, sociais e psíquicos. Neste trabalho, adotamos a definição da OMS para adolescência. O primeiro banco de dados refere-se à coleta sistematizada de informações sobre o atendimento ambulatorial multidisciplinar no Setor de Gravidez na Adolescência da Clínica Obstétrica. As gestantes adolescentes acompanhadas neste local, são atendidas por uma equipe multiprofissional composta por médicos obstetras, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fisioterapeutas no Hospital das Clínicas da FMUSP, conforme um protocolo previamente definido. O atendimento está inserido no Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante Adolescente (PIAEGA), criado em 1987, sendo um dos pioneiros no Brasil. Embora o programa tenha passado por várias reformulações ao longo dos anos, desde 1995 mantém um modelo de acompanhamento bem estruturado, com a presença contínua de dois médicos obstetras. Nesse período, foi também implementado o prontuário eletrônico no setor, permitindo o registro detalhado dos dados do acompanhamento pré-natal e do parto. Portanto, as informações obtidas tanto a partir dos pré-natais realizados quanto pelas consultas puerperais são registradas desde 1995, no formato MS Access, com a participação eventual de residentes, sob supervisão direta dos assistentes. Tais dados foram incluídos no período de 1995 a 2017. A segunda fonte de dados provém de uma planilha eletrônica, também no formato Access MS, que pertence a um sistema assistencial da Enfermaria da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP. Nele, estão contidas informações sociodemográficas, clínicas, obstétricas, de parto e nascimento tanto de

gestantes adultas quanto de adolescentes atendidas neste setor, algumas das quais não foram acompanhadas pelo setor de pré-natal multidisciplinar mencionado anteriormente. Estes dados se 29

referem a partos realizados no Hospital das Clínicas entre 2000 e 2016. Esse período foi escolhido porque o sistema foi implementado no final de 2000 e foi substituído, em 2017, pelo Sistema Gerencial MV, o que dificultou a obtenção de dados mais recentes para realização dessa pesquisa. Na união das duas fontes de dados, houve uniformização das variáveis, permanecendo as que eram comuns aos dois bancos de dados.

3.3 3.3 Elegibilidade

O primeiro banco de dados apresentava informações de 2.399 registros, enquanto o segundo abrangia um total de 28.205 registros - que englobam gestantes adolescentes e adultas. Primeiramente, foi realizado o processo de exclusão de qualquer registro duplicado. Em relação ao primeiro banco de dados, não houve descarte de nenhum dado, visto que o banco não continha duplicação de informações. Já em relação ao segundo, essa filtragem de duplicação resultou na retirada de 18.624 dados duplicados. Após a exclusão de informações duplicadas, foram excluídas do estudo as gestações que evoluíram para abortamento, definidas como idade gestacional inferior a 22 semanas ou peso fetal menor que 500 gramas, além dos casos de interrupção judicial da gravidez. Também não foram incluídas gestações gemelares e situações em que faltavam informações essenciais sobre o parto. Portanto, como critérios de elegibilidade, temos:

3.3.1 3.3.1 Critérios de Inclusão:

- Gestantes adolescentes entre 11 e 19 anos com prontuários da assistência ao parto preenchidos com dados clínicos e obstétricos; 30
- Gestantes adultas entre 20 e 34 anos com prontuários da assistência ao parto preenchidos com dados clínicos e obstétricos; - Gestação única; - Gestante inserida nas classificações de Robson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, - Assistência ao parto realizada após 22 semanas de gestação; e - Dados preenchidos sobre a assistência ao parto.

3.3.2 3.3.2 Critérios de Exclusão:

- Gestantes com idade fora do intervalo de 11 a 34 anos; - Gestantes inseridas na classificação 8 de Robson, - Gestação múltipla; e - Abortamento (< 22 semanas ou < 500 g). Dos 21.023 dados totais coletados dos dois bancos de dados, após a filtragem inicial das informações repetidas, restaram para análise 8.724 parturientes. Para garantir a qualidade da análise, foram selecionados apenas casos que apresentavam dados confiáveis sobre o parto, bem como desfechos clínicos e obstétricos, além dos critérios de elegibilidade. Sendo assim,

foram selecionadas 1.677 gestantes adolescentes (11 a 19 anos) e 7.047 adultas (20 a 34 anos), que receberam acompanhamento no HC-FMUSP - seja no ambulatório especializado e multidisciplinar para adolescentes na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas ou na Enfermaria do Hospital das Clínicas da FMUSP. 31

Todas as informações coletadas de 8.724 pacientes foram transferidas para uma planilha eletrônica no formato Excel-Microsoft para serem analisadas e classificadas de acordo com as classificações de Robson. A seguir, trataremos sobre as questões éticas do estudo e como foi realizada essa análise dos dados.

3.4 3.4 Questões Éticas

Sobre a manipulação dos dados coletados, é importante dizer que a planilha que foi construída não continha a identificação das pacientes, ou seja, garantimos o sigilo e a confidencialidade e, portanto, dispensou-se a necessidade do termo de consentimento livre e esclarecido. Ademais, o acesso aos dados foi restrito às pessoas envolvidas na pesquisa, que foram devidamente informadas sobre as exigências de confiabilidade e supervisionadas pelo pesquisador responsável. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do HC - FMUSP inserido dentro de um projeto de pesquisa maior, sob título: “Análise comparativa de aspectos demográficos, clínicos, obstétricos e neonatais de gestantes adolescentes e adultas em série histórica de 25 anos no Hospital das Clínicas da FMUSP”, aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPESQ), em 23 de junho de 2023 (número do Parecer 6.127.712), conforme Anexo 1. O estudo foi devidamente registrado na Plataforma Brasil sob o número CAAE 70155123.3.0000.0068.

3.5 3.5 Análise dos dados

Após a primeira etapa de integração dos dois bancos de dados, com a exclusão de casos duplicados, inconsistentes e de acordo com os critérios estabelecidos, pudemos avaliar os dados 32

de parto de forma comparativa. A análise estatística dos dados foi feita no software R Studio, concentrando a avaliação dos dados sociodemográficos e desfecho de parto. As variáveis qualitativas categóricas obtidas neste estudo foram apresentadas como frequência absoluta (n) e frequência relativa (%), e as variáveis quantitativas numéricas como média e desvio padrão, ou mediana e o intervalo interquartil, conforme distribuição normal ou não. Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas categóricas e a faixa etária das gestantes (adolescentes vs. adultas), utilizamos o teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher, quando apropriado. Consideramos a significância do teste estatístico de 5%. Para as variáveis quantitativas numéricas, avaliamos a distribuição dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para as variáveis de distribuição normal, apresentamos média e desvio padrão. Para as variáveis de distribuição não-paramétrica (não normal), apresentamos mediana e o intervalo interquartil

(min/máx). As análises comparativas entre gestantes adolescentes precoces, tardias e adultas foram realizadas utilizando a Classificação de Robson para estratificação, com os resultados sendo comparados entre esses grupos etários dentro de cada categoria da classificação.

4 4. Resultados

Após o tratamento dos dados, ou seja, a análise de cada caso a partir da elegibilidade, chegou-se a um número final de 8.724 participantes, sendo 1.677 parturientes adolescentes e 7.047 adultas. A fim de atender os objetivos propostos, realizamos uma análise dos dados sociodemográficos, seguida de análise do tipo de parto e, por fim, uma comparação entre os dados obtidos. 33

4.1 4.1 Dados Sociodemográficos

A seguir, serão apresentados os dados sociodemográficos das gestantes analisadas nesta pesquisa, abrangendo as seguintes variáveis: cor, estado civil e escolaridade (Tabela 1).

34

Tabela 1: Comparação dos dados sociodemográficos das participantes do estudo, incluindo 1.677 parturientes adolescentes (11 a 19 anos) e 7.047 adultas (20 a 34 anos). HC-FMUSP, 1995-2017. Dados Sociodemográficos Adolescentes (11-19 anos) Adultas (20-34 anos) Total
Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual
Cor Branca 342 56,3% 3131 60,2% 3473 59,8% Não branca 265 43,7% 2069 39,8% 2334 40,2% Total 607 100% 5200 100% 5807 100%
Estado civil Solteira sem companheiro 269 17,2% 1538 29,7% 1807 26,8% Casada 75 4,8% 1875 36,3% 1950 29,0% Solteira com companheiro 763 48,8% 2 0,0% 765 11,4% União estável 454 29,0% 1690 32,7% 2144 31,8% Separada 2 0,1% 60 1,2% 62 0,9% Viúva 0 0,0% 6 0,1% 6 0,1% Total 1563 100% 5171 100% 6734 100%
Escolaridade Analfabeta 2 0,1% 46 1% 48 0,8% < 9 anos de estudo 789 50,4% 1801 38% 2590 41% 9 a 12 anos de estudo 776 49,5% 2623 55,3% 3399 53,8% >= 13 anos de estudo 0 0,0% 275 5,8% 275 4,4% Total 1567 100% 4745 100% 6312 100%

Em relação à análise de cor das gestantes adolescentes e adultas, identificamos que temos 56,3% como brancas no grupo das adolescentes comparado com 60,2% das adulta; como não brancas temos 43,7% entre as adolescentes e 39,8% entre as adultas; o p valor neste caso é de 0,06, ou seja, a diferença não é estatisticamente significativa. Em relação ao estado civil das participantes, observamos que entre as gestantes adolescentes a maior parte (48,8%) é solteira, mas possui um companheiro. Já entre as gestantes adultas, temos dados menos discrepantes, sendo a maioria casada (36,3%), em segundo lugar as que possuem união estável (32,7%) e em terceiro as gestantes que estão solteiras e não possuem 35

companheiro (29,7%). Esses dados refletem diferenças nas dinâmicas de relacionamento entre os dois grupos, sugerindo que, entre as adolescentes, a maternidade ocorre predominantemente fora do casamento, enquanto entre as adultas há maior formalização das relações. O p valor

identificado para estas variáveis foi menor que 0,001, o que indica uma diferença significativa entre os grupos. Em relação à escolaridade, temos que a maioria das adolescentes (50,4%) apresenta menos de 9 anos de estudo, o que sugere que a maior parte das adolescentes ainda estava em idade escolar quando engravidaram e podem ter interrompido os estudos nesse nível, compatível ao que se espera nesta faixa etária. Nas adultas, 38% apresentaram menos de 9 anos de estudo, em comparação com 50,4% das adolescentes. A taxa de analfabetismo em ambos os grupos é baixa, sendo quase inexistente nas adolescentes (0,1%), porém chega a 1% das adultas gestantes do estudo. O p valor foi menor que 0,01, o que novamente indica uma diferença significativa entre os grupos.

4.2 4.2 Tipos de parto: normal, cesárea, fórcepe

Aqui apresentaremos os resultados relacionados ao tipo de parto (normal, cesárea e fórcepe) entre adolescentes e adultas (Tabela 2).

36

Tabela 2: Análise comparativa dos dados sobre os tipos de parto entre todas as participantes do estudo, incluindo 1.677 adolescentes (11 a 19 anos) e 7.047 adultas (20 a 34 anos). HC-FMUSP, 1995-2017.

Adolescentes (11-19 anos) Adultas (20-34 anos) Total

Frequência	Percentual	Frequência	Percentual	Frequência	Percentual	Tipo de parto
280	39,9%	1490	27,5%	1770	28,9%	Normal
211	30,1%	3374	62,3%	3585	58,6%	Cesárea
210	30,0%	551	10,2%	761	12,4%	Fórcepe
701	100%	5415	100%	6116	100%	Total

No total, no período analisado, somando gestantes adolescentes e adultas, tivemos 28,9% de partos normais, 58,6% de cesáreas e 12,4% de partos com fórcepe (Tabela 2; Figura 1). Figura 1 - Taxas de parto normal, cesárea e fórcepe analisados nos dados do HC - FMUSP dos últimos 25 anos.

37

A análise do tipo de parto revela que, entre as gestantes adolescentes, houve maior prevalência de parto normal (39,9%) e de uso de fórcepe (30,0%) quando comparado com gestantes adultas, que apresentaram 27,5% de parto normal e 10,2% de fórcepe. Ao comparar a porcentagem de cesáreas entre gestantes adolescentes e adultas, observamos uma menor frequência de nascimento por via cirúrgica no grupo de adolescentes. O p valor destas análises foi menor do que 0,001 o que indica uma diferença significativa entre os grupos. Para as gestantes adultas, a taxa de cesáreas foi de 62,3%, contra 30,1% em gestantes adolescentes (Figura 2).

Figura 2: Comparação de tipo de parto entre adultas e adolescentes.

38

5 5. Referências Bibliográficas

1. Freitas MV, Abramo HW, León OD. Juventude e adolescência no Brasil: referências conceituais. Ação Educativa: Programa de Juventude; 2005. 2. Unicef B. Competências para a vida: um caminho para a inclusão social [Internet]. 2019 [cited 2025 Mar 11]. Available from: https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-02/br_competencias_para_a_vida.pdf 3. World Health Organization. Appropriate technology for birth. *Lancet*. 1985 Aug 24;53:418. 4. Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). J OF RADARS. julho 1990;8:069. 5. Colombo AA. A bioética como instrumento de crítica às políticas públicas em saúde reprodutiva feminina e educação sexual no Brasil. *Rev Bras Sex Hum*. 2022;33:1056–1056. 6. Miura PO, Tardivo LS de LPC, Barrientos DMS, Egry EY, Macedo CM. Adolescence, pregnancy and domestic violence: social conditions and life projects. *Rev Bras Enferm*. 2020 Jun 1;73 Suppl 1(suppl 1):e20190111. 7. Martinez EZ, Roza DL da, Caccia-Bava M do CGG, Achcar JA, Dal-Fabbro AL. Gravidez na adolescência e características socioeconômicas dos municípios do Estado de São Paulo, Brasil: análise espacial. *Cad Saude Publica*. 2011 May;27(5):855–67. 8. Gonçalves M. Gravidez na adolescência como fator de risco para baixo peso ao recém-nascido: revisão integrativa da literatura. *Res Soc Dev*. 2024;13(9):e6413946750–e6413946750. 9. Dadoorian D. Gravidez na adolescência: um novo olhar. *Psicol Ciênc Prof*. 2003 Mar;23(1):84–91. 10. Adeyinka DA, Oladimeji O, Adekanbi TI, Adeyinka FE, Falope Y, Aimakhu C. Outcome of adolescent pregnancies in southwestern Nigeria: A case-control study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2010;8:785–9. 11. Conde-Agudelo A, Belizán JM, Lammers C. Maternal-perinatal morbidity and mortality associated with adolescent pregnancy in Latin America: Cross-sectional study. *Am J Obstet Gynecol*. 2005;192(2):342–9. 12. Souza JP, Gülmezoglu A, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Carroli G, Fawole B, et al. WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health Research Group. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. *BMC Med*. ;8:71; 2010. 13. Sandall J. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and 39 children. *Lancet*. 2018;392(10155):1349–57. 14. Li HT, Zhou YB, Liu JM. The impact of cesarean section on offspring overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis. *Int J Obes*. 2013;37(7):893–9. 15. Mascarello KC, Matijasevich A, Barros AJ, Santos IS, Zandonade E, Silveira MF. Repeat cesarean section in subsequent gestation of women from a birth cohort in Brazil. *Reprod Health*. 2017;14:1–7. 16. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, Leveno KJ, Spong CY, Thom EA. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. *Obstet Gynecol*. 2006;107(6):1226–32. 17. Pimenta MDM, Augusto MHO. *Ser Jovem' ' eSer Adulto'*: identidades, representações e trajetórias. 18. Williams J. Whitridge: Text-book of Obstetrics. D Appleton and Co. 1922;1917, . (apud Harris:250. 19. Mott ML. Assistência ao parto: Do domicílio ao hospital (1830-1960). São Paulo: Proj História; 2002. 20. Leister N, Riesco MLG. Assistência ao parto: história oral de mulheres que deram à luz

- nas décadas de 1940 a 1980. *Texto Contexto Enferm.* 2013;22:166–74. 21. Almeida MAS. Gravidez adolescente: a diversidade das situações. *Rev Bras Estud Popul.* 2002;19(2). 22. Reis AOA. Opacidade e visibilidade da paternidade na reprodução adolescente. *Rev Bras Cresc Desenv Hum.* 1997;7(2). 23. Stepto RC, Grier E. Pregnancy in the adolescent. *J Natl Med Assoc.* May; 1950. 24. Lewis L, Nash R. Pregnancy in patients under 16. *Med J.* junho 1967; 25. Hassan HM, Falls FH. The young primipara: A clinical study. *Am J Obstet Gynecol.* 1964;88(2):256–69. 26. Hutchins FL, Kendall JR, Rubino J. Experience with teenage pregnancy. *Obstet Gynecol.* 1979;54(1):1–5. 27. de Siqueira AA, Tanaka AC, de Andrade J, de Almeida PA, Santiago S, Zanatelli CC, et al. Course of pregnancy in adolescents registered at the Prenatal Service of the Geraldo de Paula Souza Health Center, São Paulo. *Rev Saude Publica.* 1981 Oct;15(5):449–54. 28. Costa CFF. Primiparidade precoce na Maternidade Prof. Monteiro de Moraes Gin Obst Bras. 1982;5(1):115–45. 29. Beleza Filho AAL, Dalacorte J, Belotto LC, Saab Neto JA, Garcia WZ. Gestação na adolescência. *J Bras Ginecol.* 1984;94(7):271–4. 30. Mathias L, Nestarez JE, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescência. I – Primigestas de 9 a 15 anos. *J Bras Ginecol.* 1985;95(3):89–91. 40
31. Mathias L, Nestarez JE, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescência. IV – Idade limite de risco reprodutivo entre adolescentes. *J Bras Ginecol.* 1985;95(4):141–3. 32. Lopez Alegria FV, Schor N, de Siqueira AAF. Gravidez na adolescência: estudo comparativo. *Rev Saúde Pública [Internet].* 1989;23(6). Available from: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101989000600005> 33. Mesquita C. Saúde da mulher e redemocratização: ideias e atores políticos na história do PAISM. In: *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH.* 2010. 34. Implantação do Programa Integrado de Assistência Educação Gestante Adolescente (PIAEGA) Ambulatorio de Obstetricia do HCFMUSP. 35. Silva LR da, Christoffel MM, Souza KV de. História, conquistas e perspectivas no cuidado à mulher e à criança. *Texto Contexto Enferm.* 2005 Dec;14(4):585–93. 36. Spitz AM, Velebil P, Koonin LM, Strauss LT, Goodman KA, Wingo P. Pregnancy, abortion, and birth rates among US adolescents—1980, 1985, and 1990. *JAMA.* 1996;275(13):989–94. 37. Creatsas G, Goumalatsos N, Deligeoroglou E, Karagitsou T, Calpaktoglou C, Arefetz N. Teenage pregnancy: comparison with two groups of older pregnant women. *J Adolesc Health.* 1991;12(1):77–81. 38. Aleixo PLP. Gestação na adolescência. In: *Academia Nacional de Medicina I Congresso Nacional - A Saude do Adolescente.* Academia Nacional de Medicina; 1991. p. 467–82. 39. Brown HL, Fan Y, Gonsoulin WJ. Obstetric complications in young teenagers. *South Med Rev.* 1991;84(1):46–8. 40. Galletta MAK, Lippi ATA, Giribola A, Miguelez J, Zugaib M. Resultados obstétricos e perinatais em gestantes adolescentes atendidas em pré-natal especializado. *Rev Ginecol Obstet (Sao Paulo).* 1997;8(1):10–9. 41. Lippi A, Galletta M, Zotto D, Caire SB, Tamaki AR, Rossi HM, et al. Estudos dos Fatores Associados à Indicação de Cesárea em Gestantes Adolescentes. *Anais do 6o. Realizado em Porto Alegre-RS.* 2000; 42. Costa M, Santos C, Sobrinho CL, Freitas JO. Ferreira KASL - Indicadores materno-infantis na adolescência e juventude: sociodemográfico, pré-natal e nascidos-vivos. *J Pediatr (Rio J).* 2001;77(3):235–42. 43. Carniel EDF, Zanolli MDL, Almeida CAA, Morcillo AM. Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco para a gravidez na adolescência em Campinas, SP, Brasil.

Rev Bras Saúde Materno Infant. 2006;6:419–26. 44. Azevedo WF, Diniz MB, Esvb F, Lmr A, Evangelista CB. Complicações da gravidez na adolescência: revisão sistemática da literatura. Einstein (Sao Paulo). 2015;13(4):618–26. 45. Velho MB. Prevalence of spontaneous, induced labour or planned caesarean section and factors associated with caesarean section in low-risk women in southern Brazil. Midwifery. 2019;79:102530. 41

32. Organization WH. Intrapartum care for a positive childbirth experience. Genève, Switzerland: World Health Organization; 2018. 47. Tembo T. The association of maternal age with adverse neonatal outcomes in Lusaka, Zambia: a prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20:1–10. 48. Socolov DG, Iorga M, Carauleanu A, Ilea C, Boiculese BI. I, Socolov RV. Pregnancy during adolescence and associated risks: an 8-year hospital-based cohort study (2007-2014) in Romania, the country with the highest rate of teenage pregnancy in Europe. Biomed Res Int. 2017;2017:8. 49. Campos ATS. Reincidência de gravidez na adolescência: fatores associados e desfechos maternos e neonatais. Ciênc Saúde Colet. 2022;27:3261–71. 50. de Oliveira GD. Nascer no Brasil: o retrato do nascimento na voz das mulheres. Rev Eletrônica Comun Informação Inov Saúde. 2015;9(2). 51. Nam JY, Oh SS, Park EC. The association between adequate prenatal care and severe maternal morbidity among teenage pregnancies: a population-based cohort study. Front Public Health. 2022;10:782143. 52. Wong SPW, Twynstra J, Gilliland JA, Cook JL, Seabrook JA. Risk factors and birth outcomes associated with teenage pregnancy: A Canadian sample. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2020 Apr;33(2):153–9. 53. Bussink-Voorend D. Health indicators of pregnant women in Tonkolili district, rural Sierra Leone. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11):3918. 54. Betran AP, Ye J, Moller AB, Souza JP, Zhang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. BMJ Glob Health. 2021;6. 55. Scholl TO, Hediger ML, Belsky DH. Prenatal care and maternal health during adolescent pregnancy: a review and meta-analysis. J Adolesc Health. 1994 Sep;15(6):444–56.